CODE 6 — DE LA SANTÉ

Version : V1.8
Alignement déclaré : Constitution V.34 ; Code 1 V1.9 ; Code 2 V1.7 ; Code 3 V1.7 ; Code 4 V1.8 ; Code 5 V1.6 ; Code 7 V1.9 ; Code 8 V1.6 ; C.1-Annex A V1.6 ; Code 9 V3.3 ; Code 10 V1.7 ; Code 11 V1.5 ; Code 12 V1.6 ; Code 13 V1.7 ; Code 14 V1.6 ; Code 15 V1.7 ; Code 16 V1.7.

TITRE PRÉLIMINAIRE — PRINCIPES FONDAMENTAUX

Art. 1 — Objet et nature juridique

1. Le présent Code régit la protection de la santé en tant que bien commun d'infrastructure, droit inviolable et condition matérielle d'existence de la Confédération, conformément à l'article 1.2 de la Constitution.
2. La santé n'est ni une marchandise, ni une prestation payante, ni un privilège lié à la possession de compétences ou à la quantité de CBO accomplie.
3. Aux fins du présent Code, on entend par santé le bien-être physique, psychique, relationnel et environnemental de la personne. Son évaluation respecte l'autodétermination individuelle et prend en compte les conditions collectives qui influent sur la santé.
4. Le présent Code régit :
    a) la prévention des risques liés à la CBO, aux Entrepôts et aux habitats ;
    b) la surveillance sanitaire et la coordination avec la sécurité des tâches ;
    c) les soins primaires, le soin des personnes fragiles et la santé mentale ;
    d) la gestion des accidents et des maladies professionnelles ;
    e) le Panier santé et l'autonomie pharmaceutique ;
    f) la confidentialité des données de santé.
5. Les compétences du présent Code se coordonnent avec celles des Codes 12 et 14. Le Conseil Santé ne remplace pas les organes compétents en matière de sécurité générale, de soin des personnes fragiles ou de protection des données.

Art. 2 — Principes

1. **Prévention.** Les activités de CBO, de production, de logistique et d'apprentissage sont organisées de manière à prévenir les atteintes à la santé avant qu'elles ne surviennent.
2. **Autodétermination.** Chaque personne décide de son propre corps et de son propre parcours de soins sur la base d'un consentement libre, éclairé et révocable. Aux mineurs et aux personnes qui ne sont pas en mesure de décider s'applique l'article 2-ter. Les mesures collectives de l'article 2-bis peuvent limiter les tâches, les activités et les déplacements dans les limites qui y sont fixées, mais ne comprennent jamais un traitement sanitaire imposé. L'article 8 reste applicable à la personne temporairement incapable en crise aiguë.
3. **Non-culpabilisation.** La maladie, l'accident et la fragilité ne constituent pas une faute et ne peuvent entraîner, par eux-mêmes, ni réduction du Panier de suffisance, ni exclusion, ni sanction. Les garanties du Code 4 s'appliquent.
4. **Proximité.** Le soin est organisé, dans la mesure du possible, dans le Cercle, dans l'Entrepôt et dans l'habitat de la personne. Le recours à des services hospitaliers ou centralisés est décidé lorsqu'il est nécessaire pour accéder à des compétences de Niveau 3 non disponibles localement.
5. **Non-marchandisation du savoir.** Il est interdit de breveter ou de soumettre à un accès payant le savoir vital et la connaissance sanitaire essentielle. La rente découlant du monopole de compétences sanitaires est interdite, conformément au Code 5, article 8.

6. **Proportionnalité et confidentialité.** Toute mesure sanitaire est limitée au but pour lequel elle est adoptée. Les informations de santé ne sont traitées que dans la mesure nécessaire et avec les garanties de l'article 11.

Art. 2-bis — Risque collectif immédiat et coordination avec l'article 8

1. On entend par **risque collectif immédiat et documenté** une situation dans laquelle un agent pathogène, un contaminant ou une condition environnementale, sur la base de données scientifiques vérifiables et enregistrées dans l'Entrepôt du savoir Santé, comporte un danger concret, actuel et grave de propagation ou de dommage pour des tiers, qui ne peut être évité par des mesures moins intrusives.

2. La constatation est engagée sur proposition du Conseil Santé et requiert :

   a) un dossier qui décrit les données, le risque, les personnes ou les groupes potentiellement exposés et les alternatives envisagées ;

   b) l'avis d'au moins deux personnes ayant une compétence de Niveau 3, indépendantes et n'appartenant pas au Cercle auteur de la proposition ;

   c) la validation de la STV applicable, lorsqu'elle est prévue.

3. Les mesures collectives sont délibérées par l'Assemblée générale selon la procédure d'urgence du Code 3. La délibération est motivée et documente la nécessité, la proportionnalité, la durée, les alternatives moins intrusives et les critères de cessation. La coordination avec le Code 14 s'applique lorsque sont en jeu des aspects de sécurité générale ou d'interruption d'activités.

3-bis. Les mesures collectives ne peuvent comprendre que :

a) l'information du public, les recommandations et l'offre gratuite de tests, de vaccinations, de prophylaxies et d'EPI, qui restent volontaires ;

b) la protection indiquée par la délibération, parmi la vaccination, la prophylaxie, les tests et les EPI, comme condition pour accomplir les tâches et pour fréquenter les lieux à risque, dans les conditions de l'alinéa 3-ter ;

c) la suspension ou la réorganisation temporaire d'activités collectives, de réunions, de tours de service de CBO, de la mobilité non essentielle et de l'hospitalité non urgente ;

d) l'isolement des personnes contagieuses et la quarantaine des personnes exposées, dans les conditions de l'alinéa 3-quater ;

e) les mesures relatives aux milieux, à l'eau, aux aliments et aux biens contaminés et, pour les zoonoses, les mesures relatives aux animaux admises par le Code 13.

Ne sont à risque que les tâches et les lieux où la contagion peut toucher des personnes particulièrement exposées : les services hospitaliers et les cabinets de soins, le soin des personnes fragiles au sens du Code 12 et, lorsque le risque concerne l'enfance, les espaces pour l'enfance et les lieux d'apprentissage collectif. Nul ne peut être exclu des soins dont il a besoin ni de l'assistance à une personne hospitalisée dont il a la responsabilité de soin ; dans ces cas, des précautions alternatives sont adoptées.

3-ter. Aucune mesure ne comprend un traitement sanitaire, un prélèvement, un test ou une vaccination pratiqués sur le corps d'une personne sans son consentement ou, pour qui ne peut pas décider seul, sans celui de la personne qui décide en application de l'article 2-ter. Qui refuse la protection indiquée en application de l'alinéa 3-bis, lettre b) :

a) peut être exclu, pour la durée de la mesure, uniquement des tâches et des lieux à risque ;

b) reçoit sans délai une autre tâche compatible, comptée dans la CBO ; si aucune n'est disponible, la suspension temporaire de l'article 11, alinéa 1, lettre c), du Code 1 s'applique. Au mineur exclu d'un espace collectif sont assurés le soin et l'apprentissage sous une autre forme ;

c) conserve le Panier, le logement, les soins, le vote, la participation délibérative et les autres droits, y compris pendant la mesure ;

d) ne commet pas d'infraction ; le refus n'est ni annoté ni communiqué au-delà de ce qui est nécessaire pour appliquer la lettre a).

3-quater. L'isolement et la quarantaine :

a) se déroulent dans le logement de la personne ou, si elle le préfère ou si le logement ne le permet pas, dans un espace approprié mis à disposition par le Cercle 1 ;

b) durent ce qu'indique le dossier de l'alinéa 2 pour l'agent en question et en tout cas pas plus de quatorze jours par personne et par exposition ; une prolongation, d'au plus quatorze jours supplémentaires, n'est admise que si deux personnes ayant une compétence L3 attestent que la personne est encore contagieuse ou, pour la quarantaine, que la période d'incubation indiquée par le dossier n'est pas terminée. Au-delà de vingt-huit jours, l'isolement de la personne encore contagieuse qui n'y consent pas ne peut être ordonné que par le Tribunal de garantie, après l'avoir entendue avec les garanties de l'article 25, alinéa 4, du Code 4, sur attestation de deux personnes L3 indépendantes au sens de l'alinéa 2, lettre b), pour des périodes ne dépassant pas quatorze jours et sans aller au-delà de la durée de la mesure collective ; à défaut, seul l'alinéa 3-ter s'applique ;

c) si la personne n'y consent pas, sont ordonnés individuellement par le Conseil Santé par un acte motivé, communiqué sans délai au Tribunal de garantie, qui les valide, les modifie ou les révoque dans un délai de vingt-quatre heures en application de l'article 34, alinéa 2, du Code 4 ; à défaut de validation, ils prennent fin. La même validation s'applique à la prolongation. L'alinéa 3 du même article ne s'applique pas ;

d) assurent à la personne la livraison du Panier, les soins, les contacts à distance avec ses proches, le vote par le Réseau et la suspension temporaire de la CBO prévue par l'article 11, alinéa 1, lettre c), du Code 1, sauf les tâches qu'elle demande à accomplir à distance ;

e) ne sont pas imposés par la force, sauf l'intervention du Corps de protection civique dans les limites de l'article 8-ter du Code 14 ; la validation de la lettre c) vaut aussi aux fins de l'alinéa 4 de cet article ;

f) pendant la transition, si la personne n'y consent pas, ne sont ordonnés que par les autorités sanitaires de l'État, en application de l'article 37 du Code 4.

3-quinquies. Pendant toute la durée de la mesure, le Conseil Santé auteur de la proposition publie, au moins chaque semaine, le dossier de l'alinéa 2, les données agrégées et anonymes sur lesquelles se fonde la mesure, leur évolution et les raisons de chaque renouvellement ou cessation, dans le respect de l'article 11.

4. La mesure :

   a) dure au maximum trente jours ;

   b) ne peut être renouvelée que par une nouvelle délibération et une nouvelle documentation ;

   c) est limitée au strict nécessaire et retient la mesure la moins intrusive appropriée ;

   d) est réexaminée, à la demande de tout membre, dans un délai de sept jours, par les membres des Cercles de garantie tirés au sort en application de l'article 17, alinéa 1-bis, du Code 3 ; l'isolement et la quarantaine ordonnés individuellement suivent en revanche la validation de l'alinéa 3-quater, lettre c) ;

   e) est enregistrée avec sa motivation, sa durée et ses critères de cessation, dans le respect de la confidentialité et des niveaux d'accès prévus par les Codes.

5. Lorsque les conditions disparaissent, la mesure cesse immédiatement. Le renouvellement ne peut pas se fonder sur la seule inertie ou sur le fait qu'un réexamen n'a pas été mené à terme.

6. Le présent article régit des mesures de santé publique destinées à la collectivité. L'article 8 régit les interventions individuelles d'urgence sanitaire concernant une personne en crise. Les deux régimes ont un objet, des conditions et des procédures distincts et ne se cumulent pas, sauf si les deux situations sont documentées.

7. Les mesures adoptées en application du présent article ne peuvent pas réduire, même pendant leur application, le Panier, le logement, les soins, le vote et la participation délibérative, ni produire d'effets

permanents sur l’accès à la CBO ou aux autres droits. D’éventuels effets supplémentaires requièrent une procédure distincte prévue par les Codes compétents et les garanties correspondantes.

8. À la cessation de la mesure, la situation juridique antérieure de la personne est rétablie. Les actes nécessaires pour documenter, vérifier ou soumettre la mesure à un audit peuvent être conservés, avec un accès limité et selon les garanties de confidentialité de l’article 11.

Art. 2-ter — Consentement des mineurs et des personnes qui ne peuvent pas décider

1. À partir de seize ans révolus, la personne donne, refuse et révoque elle-même son consentement à ses propres soins, en application de l’article 2, alinéa 2. Si, avant dix-huit ans, elle n’est pas en mesure de décider, l’alinéa 2 s’applique.

2. Jusqu’à seize ans révolus, le consentement est donné par les personnes qui ont la responsabilité de soin du mineur au sens de l’article 24.3 de la Constitution, après l’avoir informé et entendu d’une manière adaptée à son âge. L’avis du mineur a un poids croissant avec l’âge et la maturité, en application de l’article 26.2 de la Constitution. Si les personnes responsables sont plusieurs, elles décident d’un commun accord ; pour les soins urgents, le consentement de l’une d’elles suffit. La responsabilité de soin et le consentement du présent alinéa ne prennent pas fin du seul fait de la cessation du statut de membre de la personne responsable en application de l’article 29, alinéa 6-bis, du Code 4. Si personne n’exerce la responsabilité de soin, ou si aucune personne responsable ne peut être jointe en temps utile, le consentement est donné par le représentant temporaire nommé en application de l’article 7-bis, alinéa 5, du Code 12, jusqu’à la décision du Tribunal de garantie prévue par l’alinéa 3-bis du même article.

3. En cas de désaccord entre le mineur et les personnes qui en ont la responsabilité de soin, ou entre plusieurs personnes responsables, ou de conflit d’intérêts entre celles-ci et le mineur, peuvent saisir le Tribunal de garantie le mineur, chaque personne responsable, le soignant traitant ou le Conseil Soin. Le Tribunal recueille l’avis écrit d’une personne ayant une compétence sanitaire L3, indépendante et non impliquée dans les soins, tirée au sort sur la liste de l’article 36, alinéa 1, lettre b), du Code 4 ; il entend le mineur, assisté de la personne de confiance prévue par l’article 31.5 de la Constitution, et les personnes responsables ; il décide dans un délai de sept jours ou, si les soins ne peuvent pas attendre, de vingt-quatre heures, selon l’intérêt du mineur et en tenant compte de son avis conformément à l’alinéa 2. Lorsque l’attente exposerait le mineur à un danger pour sa vie ou à un dommage grave et irréversible, les soins nécessaires sont prodigués immédiatement, en application de l’article 28.2 de la Constitution, et le Tribunal en est informé.

4. Les vaccinations et les prophylaxies des mineurs suivent les alinéas 1 à 3 et ne sont jamais obligatoires. Le refus d’une vaccination ne constitue pas à lui seul une négligence grave ou un préjudice au sens de l’article 7-bis du Code 12. Pendant une mesure de l’article 2-bis, le mineur qui n’a pas la protection indiquée ne peut être exclu que des lieux à risque, dans les conditions de l’alinéa 3-ter de cet article.

5. Lorsqu’une personne adulte n’est pas en mesure de décider de ses propres soins en raison d’un état qui dure, ou dont on prévoit qu’il durera, plus de soixante jours, constaté par deux personnes indépendantes ayant une compétence sanitaire L3, le Tribunal de garantie nomme un représentant stable, si la personne n’en a pas désigné un en application de l’article 7-bis, alinéa 4, du Code 12. Le représentant est choisi selon l’ordre de l’article 7-bis, alinéa 5, du Code 12 et décide conformément à l’alinéa 6 du même article. La personne est informée et entendue dans la mesure où elle peut s’exprimer. La nomination est réexaminée par le Tribunal au moins tous les douze mois et à tout moment à la demande de la personne, de la personne de confiance, du représentant ou du Conseil Soin ; elle prend fin lorsque la personne recouvre sa capacité. Au désaccord ou au conflit d’intérêts entre le représentant et la personne s’applique l’alinéa 3. Le représentant ne peut pas consentir à des mesures coercitives, régies uniquement par l’article 8.

6. Pendant la transition, le présent article s’applique dans les limites permises par la loi en vigueur sur le consentement des mineurs et sur la représentation des personnes incapables.

CHAPITRE I — ORGANISATION, FICHES DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Art. 3 — Conseil Santé

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil Santé composé de trois à sept membres ayant des compétences de Niveau 2 ou 3 dans le domaine sanitaire, du soin, de l'agroécologie ou de la sécurité au travail. Il est l'échelon local du Cercle de compétence Médecine et Santé. Ses membres sont tirés au sort conformément à l'article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de leur mandat.

2. Le Conseil Santé :

   a) gère l'Entrepôt Santé et le Panier santé visés à l'article 10 ;

   b) rédige et met à jour, pour les aspects sanitaires relevant de sa compétence, les Fiches de sécurité des tâches de CBO ;

   c) organise la surveillance sanitaire, la gestion des EPI relevant de la compétence sanitaire et la formation L1 en matière de santé ;

   d) enregistre et analyse les accidents, les presque-accidents et les maladies professionnelles ;

   e) coordonne le soin des personnes fragiles et les interventions de santé mentale conformément au Code 12 ;

   f) coordonne avec les autres Cercles 1 la gestion des compétences rares et des urgences vitales, conformément à l'article 32 du Code 1 et au Code 14.

3. Le Conseil Santé ne dispose ni de pouvoirs d'allocation sur les biens ni de pouvoirs disciplinaires. Il ne peut pas refuser ni conditionner l'accès au Panier.

4. Le Conseil formule des propositions, documente les risques sanitaires, organise l'assistance et exerce les fonctions que lui attribue le présent Code. Ses décisions sont adoptées selon la méthode du consensus prévue par le Code 3 et sont tracées.

5. Pour chaque tâche de CBO est désigné un référent sécurité ayant une compétence L2, validée conformément au Code 5. Le référent ne remplace ni le Conseil Santé ni le Conseil Sécurité prévu par le Code 14.

Art. 4 — Fiches de sécurité, EPI et coordination avec le Code 2

1. Aucune activité de CBO ne peut être exercée sans une Fiche de sécurité en vigueur, établie selon les STV applicables et coordonnée avec les Codes 1 et 14.

2. Lorsqu'une tâche présente des aspects sanitaires et de sécurité générale, la Fiche peut être unique et intégrée ou composée de documents liés portant le même identifiant et la même version. Le Conseil Santé valide les aspects sanitaires ; le Conseil Sécurité valide les aspects de sécurité générale ; le Conseil des Entrepôts valide les aspects organisationnels relevant de sa compétence. Aucun Conseil ne peut modifier les paramètres attribués aux autres.

3. La Fiche contient au moins :

   a) les risques spécifiques ;

   b) les EPI et les protections collectives nécessaires ;

   c) les procédures opérationnelles ;

   d) les erreurs typiques et les mesures pour les prévenir ;

   e) les conditions de suspension ;

   f) les références aux STV applicables ;

   g) les limites d'exposition et les pauses requises ;

   h) la formation minimale nécessaire ;

i) la date, la version, les responsables et les conditions de révision.

4. Les EPI sont des biens communs et sont fournis gratuitement. Ils sont accessibles, maintenus en bon état et tracés par les acteurs compétents pour leur garde et leur approvisionnement. L’absence d’un EPI critique prévu par la Fiche entraîne la suspension immédiate de l’activité concernée et ne constitue pas une violation imputable à la personne à qui l’EPI n’a pas été fourni. L’obligation de mettre à disposition les EPI incombe au Cercle responsable de l’activité.

5. Tout membre peut interrompre une activité lorsqu’il constate un risque grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. L’interruption est communiquée dès que possible au responsable opérationnel et au Conseil compétent ; elle ne peut pas entraîner de représailles si elle est effectuée de bonne foi. Le Code 14 et, pour la continuité logistique, l’article 32, alinéa 3, du Code 1 s’appliquent.

6. La STV d’un bien comprend les aspects de sécurité sanitaire relatifs à la production, à l’usage, à l’entretien et à l’élimination. La STV est coordonnée avec la Fiche de sécurité et ne la remplace pas lorsque celle-ci est requise pour une tâche déterminée.

Art. 5 — Surveillance sanitaire, caractère volontaire et conditions de sécurité

1. La surveillance sanitaire est volontaire en tant que parcours général de soin et de prévention. Pour les tâches identifiées en application de l’alinéa 2, une évaluation d’aptitude peut constituer une condition technique pour l’exercice autonome de cette tâche déterminée ; elle ne constitue pas une obligation sanitaire générale.

2. Les règles suivantes s’appliquent :

   a) pour les activités de CBO à risque nul ou faible, aucune visite médicale obligatoire n’est requise ;

   b) pour les activités à risque moyen ou élevé, classées selon les STV et la Fiche de sécurité, l’évaluation d’aptitude n’est requise que lorsqu’elle est nécessaire à la sécurité de la tâche exercée de manière autonome ;

   c) l’évaluation d’aptitude n’est pas une condition pour accéder au Panier, participer aux délibérations ou appartenir à la Communauté ;

   d) la personne qui refuse la visite médicale nécessaire pour une tâche à risque moyen ou élevé n’exerce pas de manière autonome cette tâche déterminée, mais conserve le Panier de suffisance, l’accès aux autres tâches de CBO compatibles et le droit à une tâche de remplacement adaptée. Le refus ne constitue pas une infraction et n’est pas enregistré comme une mention préjudiciable ;

   e) la visite médicale périodique prévue pour une compétence sanitaire L3 à haut risque peut être une condition du maintien de la validation correspondante, conformément à l’article 4, alinéa 5, du Code 5. Le refus entraîne, si nécessaire, la suspension de la validation concernée, et non une sanction.

3. Les évaluations sanitaires peuvent comprendre :

   a) une visite médicale initiale pour les tâches à risque moyen ou élevé, lorsqu’elle est nécessaire en application de l’alinéa 2 ;

   b) une visite médicale périodique pour les compétences L3, au moins tous les deux ans, ou chaque année en cas d’exposition continue, selon les STV applicables ;

   c) une visite médicale demandée par la personne à tout moment ;

   d) une visite médicale consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle.

4. L’avis est descriptif et limité à la tâche concernée. Il peut indiquer :

   a) l’aptitude ;

   b) l’aptitude avec aménagements ;

   c) l’aptitude avec restrictions temporaires ;

   d) la suspension temporaire à titre de précaution de la tâche, avec maintien du Panier et proposition d’une CBO de remplacement.

5. L’inaptitude définitive à une tâche déterminée ne peut être prononcée que par un Collège de réexamen extérieur selon les garanties du Code 4, article 17. Le Collège est composé :

a) d’une personne ayant une compétence sanitaire L3, tirée au sort et n’appartenant pas au Cercle de la personne concernée ;

b) d’une personne du Conseil Qualité non impliquée dans la procédure ;

c) d’une personne tirée au sort parmi les membres de l’Assemblée d’un Cercle 1 autre que celui concerné, chargée de la garantie procédurale.

6. Avant la décision, le Collège recueille l’avis écrit de deux personnes ayant une compétence sanitaire L3, indépendantes, non impliquées dans les avis antérieurs et, le cas échéant, de spécialités différentes. Les personnes qui rendent l’avis ne font pas partie du Collège et ne participent pas à la décision.

7. Aucun membre du Collège ne peut avoir rendu un avis d’aptitude antérieur sur la même personne et la même tâche. Les avis sont mis à la disposition de la personne concernée avant la décision, sous réserve des restrictions strictement nécessaires pour protéger les données de santé de tiers.

8. La décision est motivée et tracée. Contre l’inaptitude définitive, un recours est admis dans un délai de quatorze jours devant un nouveau Collège extérieur, composé de personnes différentes. Le recours est admis pour :

a) vice de procédure ;

b) déraisonnabilité technique manifeste ;

c) discrimination ;

d) disproportion manifeste.

Le Code 4, article 17, et le Code 5, article 9, s’appliquent. Le Collège de second degré ne peut pas aggraver la situation de l’auteur du recours.

9. Pendant la procédure de constatation de l’inaptitude définitive, la personne conserve le Panier de suffisance et reçoit une proposition de CBO de remplacement compatible.

10. Aucune donnée de santé ne peut être utilisée pour limiter l’accès aux délibérations, au Panier ou à l’apprentissage.

CHAPITRE II — SOIN, FRAGILITÉ ET SANTÉ MENTALE

Art. 6 — Soins primaires et Entrepôt Santé

1. Chaque Entrepôt dispose d’un Entrepôt Santé et d’un Panier santé minimal. La liste du Panier santé et la dotation minimale de l’Entrepôt Santé sont proposées par les Conseils Santé en coordination fédérée, en tant qu’échelons du Cercle de compétence Médecine et Santé, au moyen d’une STV adoptée en application de l’article 3-bis du Code 2, et sont approuvées par l’Assemblée avec l’Annexe technique prévue à l’article 18, alinéa 2, du Code 1. Le Panier comprend au moins :

a) les médicaments essentiels vitaux ;

b) le matériel de premiers secours ;

c) les EPI relevant de la compétence sanitaire ;

d) les instruments de diagnostic de base ;

e) la documentation et les STV sanitaires validées.

2. Les soins primaires sont organisés au moyen du tutorat et de cabinets médicaux de Cercle, avec la participation de compétences L2 et L3. La personne choisit parmi les compétences disponibles, y compris celles qui relèvent d’autres Cercles.

3. L’IA prévue par le Code 7 peut appuyer l’indexation des protocoles, la recherche d’informations et les rappels. Elle ne peut pas formuler de manière autonome de diagnostic, déterminer l’aptitude ou décider du traitement.

4. Lorsqu’une compétence n’est pas disponible localement, le Conseil Santé active le réseau entre Cercles et le Registre des dépendances prévu par le Code 15. Les mesures possibles comprennent :

a) l’envoi de la personne au service compétent ;

b) l’envoi temporaire de la compétence au Cercle concerné ;

c) le télé-tutorat supervisé par une personne L3, lorsqu’il est approprié et sûr.

5. La modalité choisie respecte la volonté de la personne, la confidentialité médicale et la continuité des soins.

6. La protection de la santé s’articule selon les trois niveaux intégrés de l’article 28.1 de la Constitution : l’IA personnelle hors ligne à fonction préventive, conformément à l’article 5-bis du Code 7 ; les soignants de la Communauté de base ; les centres de haute spécialisation du Cercle 3.

Art. 7 — Fragilité, interdépendance et soin

1. Les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes enceintes ou en période post-partum, les personnes en deuil ou en situation de crise ont droit à une protection renforcée et, si nécessaire, à la modulation de la CBO en application de l’article 11 du Code 1 et du Code 12.

2. Le soin des personnes fragiles relève de la CBO de Liste A. Dans la hiérarchie de l’article 32 du Code 1, les prestations du Panier soin des niveaux 1 et 2 suivent la lettre b) de l’alinéa 1 et le Code 12 ; les autres activités de soin suivent la lettre d) et précèdent la gestion des biens périssables, en application de l’alinéa 1-ter du même article.

3. Les activités de soin ne peuvent pas être différées pour cause de carence logistique ni pour la gestion des biens périssables, sauf si les priorités de l’article 32, alinéa 1, lettres a) et b), du Code 1 l’exigent, y compris la distribution des aliments du Panier. La décision de report est motivée et doit prévoir, si possible, une mesure de substitution.

4. Chaque Plan CBO comprend une part de soin et de tutorat. Le soin n’est pas considéré comme une activité résiduelle à exercer seulement après la satisfaction des autres besoins.

5. La modulation de la CBO n’entraîne ni réduction du Panier de suffisance ni mentions préjudiciables.

Art. 8 — Santé mentale et protocole de crise aiguë

1. La santé mentale fait partie intégrante de la santé. La détresse, l’épuisement professionnel, le conflit et le traumatisme ne constituent ni une faute ni une faiblesse individuelle.

2. Le Conseil Santé garantit, directement ou en coordination avec le Code 12 :

a) des espaces d’écoute ;

b) des groupes de parole ;

c) un tutorat psychologique L2 ou L3 ;

d) la réduction temporaire de la charge de CBO, lorsqu’elle est nécessaire ;

e) le soutien entre pairs ;

f) l’accès à des compétences spécialisées sans liste d’attente interne injustifiée.

3. En cas de crise aiguë s’applique, en règle générale, un protocole de protection non coercitif, fondé sur :

a) la présence et l’écoute ;

b) la mise en sécurité relationnelle et environnementale ;

c) la proposition d’un soutien ;

d) la participation, si la personne le souhaite, d’une personne de confiance qu’elle a désignée.

4. Une mesure coercitive immédiate n’est admise que si les conditions suivantes sont réunies cumulativement :

a) il existe un risque vital immédiat et concret pour la personne ou pour des tiers, documenté sur le moment par deux personnes ayant une compétence L3, dont au moins une dans le domaine sanitaire ;

b) la personne est temporairement incapable d’exprimer un consentement valable ;

c) il n’existe pas, dans l’immédiat, de mesure moins intrusive également efficace.

5. Lorsque les deux compétences L3 ne sont pas immédiatement disponibles, les procédures de recherche fédérée ou de télé-tutorat prévues à l’article 13 du Code 15 sont déclenchées sans délai. Dans l’attente, seules sont admises les mesures non coercitives nécessaires à la mise en sécurité immédiate.

6. L’intervention coercitive éventuellement adoptée :

   a) est limitée au temps strictement nécessaire pour écarter le risque vital ;

   b) est effectuée en présence de deux personnes L3, lorsqu’elles sont immédiatement disponibles ;

   c) est communiquée sans délai au Tribunal de garantie pour la validation de l’alinéa 7 et au Cercle de garantie ;

   d) est documentée sur le Réseau avec un accès réglementé ;

   e) est communiquée à la personne de confiance désignée, lorsque cela est possible ;

   f) cesse immédiatement lorsque les conditions disparaissent.

7. Dans un délai de vingt-quatre heures à compter du début de la mesure, le Tribunal de garantie, en application de l’article 27, alinéa 3, du Code 4, la valide, la modifie ou la révoque. Il vérifie les conditions de l’alinéa 4, la nécessité et la proportionnalité sur la base de la documentation des deux personnes L3 et, lorsque cela est possible, après avoir entendu la personne, son représentant et la personne de confiance. Il ne procède pas à une évaluation clinique, qui reste de la compétence des personnes soignantes L3. À défaut de validation dans le délai, la mesure prend fin. Si le Corps de protection civique intervient, la validation du présent alinéa tient lieu de celle prévue par l’article 8-ter, alinéa 4, du Code 14.

8. Après la crise, un parcours de soins volontaire est proposé à la personne.

9. La contention punitive, l’isolement utilisé comme sanction et la sédation punitive sont toujours interdits.

10. La mesure coercitive :

    a) est réévaluée par les deux personnes L3 au moins toutes les douze heures et, pendant la contention physique, au moins toutes les heures ; chaque réévaluation est documentée ;

    b) après la validation, dure au plus soixante-douze heures et ne peut être prolongée que par une nouvelle validation du Tribunal de garantie, demandée avant l’échéance sur la base d’une nouvelle attestation de deux personnes L3, pour des périodes ne dépassant pas soixante-douze heures ; à défaut de nouvelle validation avant l’échéance, la mesure prend fin ;

    c) ne peut pas dépasser quatorze jours au total. À l’échéance, la mesure prend fin même si le risque persiste ; sont assurés sans interruption la présence continue de personnes formées, la mise en sécurité relationnelle et environnementale de l’alinéa 3 et l’offre de soins, et la personne peut rester volontairement sur le lieu de soin. Une nouvelle mesure coercitive n’est admise que pour un nouvel épisode aigu, dans les conditions de l’alinéa 4 attestées par deux personnes L3 autres que celles qui ont attesté la mesure précédente, et avec la validation d’un Tribunal de garantie dans une autre composition, qui vérifie expressément qu’il ne s’agit pas de la poursuite de la mesure qui a pris fin. Sur une période de quatre-vingt-dix jours, les mesures coercitives ne peuvent pas dépasser vingt-huit jours au total ;

    d) est révoquée à tout moment par le Tribunal de garantie, lorsque ses conditions disparaissent, à la demande de la personne, de son représentant ou de la personne de confiance ; la demande est tranchée dans un délai de vingt-quatre heures.

Le représentant ne peut pas consentir à une mesure coercitive à la place de la personne : seul le présent article s’applique. Pendant la transition, aucune mesure coercitive interne n’est exécutée ; toute intervention est limitée à ce que permet la loi en vigueur et les services d’urgence et les autorités sanitaires compétentes sont alertés, en application de l’article 37 du Code 4.

11. Il est interdit d’inscrire des étiquettes stigmatisantes dans le Portfolio personnel.

Art. 8-bis — Directives anticipées et fin de vie

1. Les directives anticipées sont contraignantes, en application de l’article 27.3 de la Constitution. Elles sont rédigées par la personne, avec l’assistance éventuelle de sa propre IA personnelle hors ligne et en présence de deux témoins ; elles sont conservées dans le Nœud personnel et, si la personne le souhaite, auprès du Conseil Santé de manière confidentielle. Elles sont révocables et modifiables à tout moment.
2. Par ses directives anticipées, la personne peut désigner son représentant pour le cas d’incapacité, en application de l’article 7-bis du Code 12.
3. Nul ne peut être soumis contre sa volonté à un acharnement thérapeutique. Les soins palliatifs et le soulagement de la douleur font partie du Panier santé.
4. Le droit au maintien à domicile est garanti, avec le soutien communautaire par roulement prévu par le Code 12. Les Maisons communes autogérées relèvent du choix de la personne et ne peuvent pas constituer une destination imposée.

CHAPITRE III — ACCIDENTS, MÉDICAMENTS, CONFIDENTIALITÉ ET AUTONOMIE

Art. 9 — Accidents, presque-accidents et maladies professionnelles

1. Tout accident, presque-accident ou soupçon de maladie professionnelle est signalé et enregistré sans délai. Le registre opérationnel ne contient que les informations nécessaires à l’analyse de l’événement, notamment :
   a) la description des faits ;
   b) la tâche exercée ;
   c) la Fiche de sécurité applicable ;
   d) les EPI et les protections disponibles ;
   e) les conditions opérationnelles pertinentes ;
   f) la date et l’heure de l’événement.
2. Les données d’identification et de santé sont conservées séparément et avec un accès confidentiel conformément à l’article 7 du Code 14 et à l’article 11 du présent Code. Les informations publiées sont agrégées et anonymisées.
3. L’analyse distingue, sans présumer automatiquement une responsabilité individuelle :
   a) l’usure ou le cas fortuit, qui entraînent la révision des STV et de l’organisation, sans responsabilité individuelle automatique ;
   b) les carences organisationnelles, qui requièrent la révision des mesures par le Cercle responsable et par le Conseil Santé ;
   c) les conduites intentionnelles ou les autres conduites individuelles pertinentes, qui sont traitées conformément au Code 4.
4. La personne accidentée a droit aux soins, au maintien du Panier et, pendant la convalescence, à la proposition d’une CBO de remplacement adaptée, lorsqu’elle est compatible avec son état.
5. Les Conseils Santé, en coordination fédérée en tant qu’échelons du Cercle de compétence Médecine et Santé, procèdent au moins chaque trimestre à une analyse agrégée des accidents et des presque-accidents afin de proposer la mise à jour des STV du Code 2 et des Fiches de sécurité.
6. Le cycle de prévention comprend : l’enregistrement de l’événement, l’analyse des causes, la mise à jour des mesures, la révision des STV et la prévention des événements futurs.

Art. 10 — Panier santé, médicaments, phytothérapie et expérimentation

1. Le Panier santé fait partie du Panier de suffisance prévu par le Code 1. Il comprend les biens vitaux dont l’indisponibilité peut provoquer une urgence vitale de niveau 1.

2. La Confédération poursuit l’autonomie dans la production ou l’approvisionnement fédéré de médicaments essentiels non brevetés et de dispositifs réutilisables, selon les STV du Code 2. Les dépendances critiques à l’égard de fournisseurs extérieurs sont inscrites au Registre des dépendances prévu par le Code 15.

3. On entend par **phytothérapie validée** une préparation végétale accompagnée d’une STV en vigueur qui indique au moins :

   a) l’espèce et la partie utilisée ;

   b) le dosage ;

   c) les indications et les contre-indications ;

   d) les interactions connues ;

   e) les données disponibles et leurs limites ;

   f) les modalités de préparation et de conservation.

L’usage traditionnel, à lui seul, ne constitue pas une validation. Chaque préparation validée est inscrite au Registre des STV Santé.

4. La dépendance propriétaire critique dont dépendraient des médicaments vitaux, des dispositifs de diagnostic essentiels ou des EPI est interdite. Les articles 4 et 5 du Code 2 et les dispositions du Code 15 s’appliquent.

5. Aucune expérimentation sanitaire ne peut être menée sur des membres sans un consentement libre, éclairé, spécifique et révocable. Le consentement est documenté par écrit après la fourniture d’informations compréhensibles sur les risques, les bénéfices, les alternatives et le droit de retrait.

6. L’expérimentation requiert au préalable :

   a) l’approbation d’un Collège extérieur tiré au sort conformément au Code 4, article 17, composé de trois personnes ayant une compétence sanitaire L3 non impliquées dans l’expérimentation ;

   b) l’avis du Cercle de garantie sur le consentement et sur la proportionnalité ;

   c) la délibération de l’Assemblée générale conformément au Code 3.

7. L’expérimentation sur des mineurs, sur des personnes en crise aiguë au sens de l’article 8 ou sur des personnes temporairement privées de la capacité d’exprimer leur consentement est interdite, sauf dans le cas exceptionnel où elle vise à procurer un bénéfice direct et spécifique à la personne elle-même. Dans ce cas, toutes les conditions suivantes doivent être réunies cumulativement :

   a) le consentement donné conformément à l’article 2-ter : pour le mineur, par lui-même s’il a seize ans révolus, sinon par les personnes qui en ont la responsabilité de soin ; pour la personne incapable, par le représentant désigné ou nommé en application de l’article 7-bis du Code 12 ou de l’article 2-ter, alinéa 5. La personne de confiance n’est pas considérée comme représentant, sauf si elle a été formellement désignée pour cette fonction ;

   b) si le représentant n’est pas disponible, l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article 7-bis du Code 12 pour la personne temporairement incapable, y compris la nomination en urgence d’un représentant par l’organe compétent ;

   c) l’avis conforme écrit de deux personnes L3 indépendantes et non impliquées, attestant le bénéfice direct, l’absence d’alternatives d’efficacité comparable et la proportionnalité du risque ;

   d) l’autorisation du Cercle de garantie sur les aspects de consentement et de proportionnalité ;

   e) la délibération de l’Assemblée générale conformément au Code 3, à la majorité qualifiée et avec traçage des positions exprimées ;

   f) l’écoute et le respect de la volonté de la personne dans la mesure où elle est en état de l’exprimer.

L’absence d’une seule de ces conditions empêche le lancement de l’expérimentation.

8. Toute expérimentation doit prévoir le traçage, la couverture des responsabilités collectives, l’accès aux

soins pour les éventuelles conséquences et le droit de retrait immédiat sans préjudice.

9. La violation des alinéas 5 à 8 constitue un vice de procédure grave et entraîne l’application du Code 4, y compris les effets de nullité et les obligations de réparation.

Art. 11 — Confidentialité médicale et séparation des données

1. La personne à laquelle se rapporte la donnée de santé en conserve la maîtrise. Le Système fiduciaire du Cercle exerce des fonctions de garde et de gestion technique, sans pouvoir utiliser les données à des fins propres ou incompatibles.
2. L’accès aux données de santé est réglé comme suit :

   a) l’accès ordinaire appartient à la personne concernée et à la personne de confiance qu’elle a désignée, dans les limites du consentement ;

   b) le Conseil Santé peut accéder aux informations nécessaires à la surveillance sanitaire, en se limitant, en règle générale, aux avis d’aptitude et aux aménagements et non aux diagnostics détaillés ;

   c) le Cercle de garantie peut accéder aux données nécessaires pour statuer sur un recours, selon une procédure tracée et avec un accès limité ;

   d) en l’absence de consentement, l’accès du Conseil Santé n’est admis que lorsqu’il est nécessaire pour exécuter une mesure collective valablement délibérée en application de l’article 2-bis. L’accès est limité aux données strictement nécessaires, proportionné et temporaire ; il est tracé et, lorsque cela est possible, communiqué à la personne concernée. Le réexamen par le Cercle de garantie est admis dans un délai de sept jours.
3. L’Entrepôt du savoir contient exclusivement :

   a) des Fiches de sécurité dépourvues de données de santé individuelles ;

   b) des STV sanitaires anonymisées ;

   c) des statistiques agrégées sur les accidents ;

   d) des protocoles de soins validés.

Il ne contient pas de données de santé individuelles.

4. La publication de données de santé nominatives, de listes de pathologies rattachables à des personnes ou de cartes individuelles de fragilité est interdite. La violation constitue un vice de procédure grave conformément au Code 4.
5. Toute personne a le droit :

   a) d’obtenir une copie de ses propres données de santé ;

   b) d’en demander la rectification ;

   c) d’en demander l’effacement lorsqu’elles ne sont plus pertinentes ou nécessaires ;

   d) de demander l’effacement ou l’oubli d’épisodes révolus, sauf les mesures collectives documentées et valablement délibérées en application de l’article 2-bis, dans la limite des informations strictement nécessaires.
6. L’effacement ou la rectification de la donnée personnelle n’entraîne pas l’effacement d’informations déjà rendues irréversiblement anonymes et utilisées pour des statistiques, des analyses épidémiologiques ou la mise à jour des STV. Les données personnelles sont tenues séparées des données statistiques anonymes et ne doivent pas pouvoir être reconstituées.

Art. 12 — Dispositions transitoires et liens

1. Le présent Code se coordonne avec :

   a) le Code 1, articles 27, 29, 31 et 32 ;

   b) le Code 2, pour les STV et la validation des biens ;

c) le Code 3, pour les procédures d’urgence et les délibérations ;

d) le Code 4, article 17, pour le Collège de réexamen et les garanties ;

e) le Code 5, pour les compétences L2 et L3, l’article 4, alinéa 2, lettre c), l’article 4, alinéa 5, et l’article 10 ;

f) le Code 12, pour le soin des personnes fragiles ;

g) le Code 14, pour la sécurité générale ;

h) le Code 15, pour le Registre des dépendances.

2. La validation provisoire sanitaire prévue à l’article 10 du Code 5 s’applique. Toute personne qui exerce une fonction sanitaire à haut risque à la date d’entrée en vigueur peut conserver une validation provisoire :

   a) pendant six mois pour les fonctions correspondant au Niveau 3 du Code 5 ;

   b) pendant douze mois pour les fonctions correspondant au Niveau 2 du Code 5.

Sont requis l’inscription au parcours de validation dans un délai de trente jours, la supervision renforcée, le respect des STV et la traçabilité des activités. Pendant la période provisoire, la personne ne peut pas valider les compétences d’autrui.

3. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 met en place un Entrepôt Santé minimal et établit les Fiches de sécurité pour les tâches sanitaires et de sécurité sanitaire classées L3 et en activité, conformément au Code 5, article 4, alinéa 2, lettre c).

4. Pour les tâches L3 non sanitaires, le Code 5 et le Code 14 s’appliquent ; le présent Code n’en régit pas la validation technique.

5. Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur, un audit fédéré est mené sur l’autonomie pharmaceutique et sur les EPI, avec inscription des dépendances critiques au Registre des dépendances du Code 15.